

ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΟΞΕΑ

Γενικά: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται χημικές ουσίες, όπως: το Θεικό οξύ (βιτριόλι), το Υδροχλωρικό οξύ, το Νιτρικό οξύ (Aqua forte) και το Υδροφθόριο. Κατάποση διαβρωτικών οξέων συμβαίνει συχνότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες (Ινδία, Μπαγκλαντές, Νεπάλ), όπου το υδροχλωρικό και το θεικό οξύ είναι ουσίες ευκόλως προσβάσιμες για τον πληθυσμό.

Τα ισχυρά οξέα προκαλούν ηχητική νέκρωση και σχηματισμό νεκρωτικής στιβάδας, που περιορίζει, μερικώς, την επέκταση της ιστικής βλάβης εν τω βάθει. Τις εντονότερες βλάβες στο βλεννογόνο του πεπτικού σωλήνα προκαλεί το θεικό οξύ και ακολουθεί το νιτρικό.

Κλινική εικόνα: Μετά από την κατάποση ενός καυστικού οξέος, ο ασθενής προσέρχεται στο ΤΕΠ με φοβερό καυστικό άλγος στο στόμα, το φάρυγγα, τον θώρακα και το επιγάστριο. Μπορεί να εμφανίζει επίσης έντονη δίψα, δυσκαταποσία, ερυγές, μετεωρισμό, σύσπαση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Μεγαλύτερες βλάβες εμφανίζονται όταν το διαβρωτικό οξύ ληφθεί με άδειο στομάχι. Εφόσον τα οξέα λιμνάσουν εντός του στομάχου μπορεί να παρατηρηθεί γαστρορραγία, γαστρική νέκρωση ή/και διάτρηση. Ο ασθενής μπορεί επίσης να εμφανίσει βλεννοαιματηρούς εμέτους, σταδιακά σκοτεινόχρους και διάρροιες με πρόσμιξη αίματος.

Παρατηρείται πτώση της ΑΠ, ενίοτε σε επίπεδα shock (MAP < 65 mmHg), διαταραχές στο σφυγμό και στο ΗΚΓ (αρρυθμίες) και γενικά εικόνα collapsus και πιθανώς κώμα.

Αν το καυστικό οξύ έχει έλθει σε επαφή με το δέρμα τότε ο ασθενής νιώθει έντονο πόνο με σχηματισμό κίτρινων ή μελανών εσχάρων και οι βλάβες αντιμετωπίζονται σαν έγκαυμα.

Σε επαφή των οξέων με τα μάτια προκαλούνται επιφανειακές βλάβες, όπως οίδημα και καταστροφή του κερατοειδούς με έντονη δακρύρροια, αφόρητο πόνο και φωτοφοβία.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. **Απαγορεύεται η χορήγηση εμετικών (σιρόπι Ιπεκακουάνας) και η πρόκληση εμέτου.**
2. **Απαγορεύεται η έκπλυση στομάχου (είτε το θύμα είναι ληθαργικό, είτε σε εγρήγορση).**
3. **Απαγορεύεται η χορήγηση αλκαλικών ουσιών (και αντιόξινων) ως αντιδότων, γιατί προκαλείται έντονα εξώθερμη αντίδραση (έγκαυμα) εντός του πεπτικού σωλήνα.**
4. **Απαγορεύεται η χορήγηση ενεργού άνθρακα (Toxicarb) ως προσροφητικού μέσου.**
5. Προσπαθούμε να επιτύχουμε αραίωση του οξέος, με την πόση 50-150 ml γάλακτος για τα παιδιά, καθώς και πόση 60-300 ml γάλακτος για τους ενήλικες. Ένδειξη έχει επίσης και η χορήγηση λευκώματος αβγού (2-4 ασπράδια) και ελαιολάδου (3-5 κουταλιές σούπας).
6. Βασικό μέλημα αποτελεί η διαχείριση του αεραγωγού και η διατήρηση της οξυγόνωσης του ασθενούς. Χορηγούμε O₂ στα 8-12 lt/min και μεριμνούμε ώστε SpO₂ > 90-92%.
7. Μερικοί, συνιστούν την τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα Levin για την απομάκρυνση ποσότητας του καυστικού οξέος και διενέργεια γαστρικών πλύσεων με φυσιολογικό ορό, εφόσον αυτό επιτευχθεί εντός των πρώτων 10-15 λεπτών από τη στιγμή της κατάποσης.
8. Τοποθετούμε ευρεία (#18G) 3way φλεβική γραμμή, για να υποστηρίξουμε αιμοδυναμικά τον ασθενή μας, με 1000 ml NaCl 0,9 % ή/και με 1000 ml διαλύματος Ringer's.
9. Επί αφόρητου πόνου, τοποθετούμε 1 amp. Μορφίνη ή Πεθιδίνη ή Τραμαδόλη, στον ορό.
10. Για τον έλεγχο της διέγερσης, χορηγούμε 1 amp. Stedon 10 mg, εντός 100 ml N/S (iv).
11. Στην περίπτωση επαφής του οξέος με το δέρμα, απαιτείται άμεσα έκπλυση με νερό για 10-20 λεπτά (εκτός από το H₂SO₄ που απαιτεί έκπλυση μόνο για 45-90 sec και σκούπισμα με πετσέτα ή σφουγγάρι προς αποφυγή περαιτέρω βλάβης). Αντιμετωπίζουμε τις δερματικές βλάβες όπως επί θερμικού εγκαύματος, ιδίως για βλάβες > 15% της επιφάνειας σώματος.
12. Σε περίπτωση χημικού εγκαύματος ή κατάποσης υδροφθορίου (HF), επειδή τα διαλύματα HF δεσμεύουν μεγάλη ποσότητα ασβεστίου (Ca⁺⁺), χορηγούμε Γλυκονικό ασβέστιο, ήτοι 2 amp. Calcium Gluconate, εντός ορού 500 ml NaCl 0,9%, βραδέως ενδοφλεβίως.
13. Διακομιδή άμεσα, στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring ΗΚΓ, BP, HR, RR και SpO₂.

